

PATOLOGÍA DE LA EXTREMIDAD INFERIOR: LESIONES TRAUMÁTICAS Y FRACTURAS DEL PIE

G. Alonso Claro, A. Roces Fernández, F.J. Madera González.

FRACTURAS DE LOS HUESOS DEL RETROPIE

Fracturas de astragalo

Mecanismo lesional:

Son fracturas poco frecuentes (0.4% del total). Suelen producirse por compresión axial en el contexto de traumatismos de alta energía, como las caídas de altura y los accidentes de tráfico. Las más frecuentes son las fracturas del cuello (50%). Son lesiones graves, difíciles de tratar y de pronóstico oscuro.

Exploración física:

El dolor intenso, la gran tumefacción del pie y el tobillo nos han de hacer sospechar esta lesión. Suelen asociarse con fracturas de calcáneo y maleolares. Lesiones abiertas hasta en un 25% de los casos.



Pruebas complementarias: Radiografías AP y de mortaja del tobillo, lateral de tobillo y pie. Muchas veces es necesario un TAC.

Tratamiento:

Si existe una luxación del astrágalo lo más importante es reducir la luxación de forma anatómica lo antes posible, para evitar el compromiso vascular y de partes blandas del pie. Posteriormente, inmovilizar con una férula suropédica la extremidad. El tratamiento definitivo de la mayoría de estas fracturas es quirúrgico.

Fracturas de calcáneo

Mecanismo lesional:

Es el mayor de los huesos del tarso. Las fracturas del calcáneo son las más frecuentes de los huesos del tarso y están relacionadas con caídas de altura o accidentes de tráfico, por un mecanismo de compresión axial.

Se presentan en traumatismos de alta energía, por lo cual siempre hay que despistar lesiones en otras localizaciones: meseta tibial, columna lumbar y retropié contralateral.

Exploración física:

Se presentan con dolor intenso e incapacidad para el apoyo, equimosis y tumefacción. El talón está ensanchado, acortado y desviado en valgo. El arco plantar se aplana. La presencia de un hematoma plantar (signo de Mondor) es característica.

Pruebas complementarias:

- Proyecciones AP, lateral de pie
- axial de calcáneo (de Harris)
- oblicua (de Broden)

Muchas veces se necesita un estudio TAC para determinar bien el trazo de fractura.

Tratamiento

En las fracturas no desplazadas o que conserven la morfología del calcáneo o pacientes que rechacen o que no toleren la cirugía el tratamiento consiste en la inmovilización con una férula suropédica a 90° y descarga completa.

En fracturas desplazadas, abiertas o con alteración del complejo aquileo el tratamiento es quirúrgico.





Radriografía anteroposterior y lateral de calcaneo.

Fracturas de los huesos del mediopie (escafoides tarsiano, cuboides y cuñas)

Mecanismo lesional:

Las fracturas suelen ocurrir en traumatismos de alta energía por compresión. Son fracturas raras de forma aislada. Las avulsiones del escafoides ocurren en el contexto de un esguince severo.

Exploración física:

El dolor junto con tumefacción y hematoma local.

Pruebas complementarias:

El diagnóstico mediante radiología convencional a veces es difícil y es necesaria la petición de un TAC para descartar una fractura.

Tratamiento

El tratamiento es una bota de yeso en fracturas no desplazadas o incompletas y quirúrgicas en el resto.



Fractura – luxación escafoides tarsiano

FRACTURA-LUXACIÓN DE LA ARTICULACIÓN MEDIO TARSIANA (CHOPART)

Lesión infrecuente, el pie se acorta y deforma, desapareciendo los arcos normales del pie. Suele asociar fracturas del escafoides tarsiano o de la cabeza del astrágalo.

Exploración física:

La presentación clínica es variable

Pruebas complementarias: Rx AP y Lateral suelen ser diagnósticas.

Tratamiento:

Precisan de reducción bajo anestesia y osteosíntesis si la reducción es inestable.



Fractura de chopart

FRACTURA-LUXACIÓN DE LA ARTICULACIÓN TARSOMETATARSIANA (LISFRANC)**Mecanismo lesional:**

Lesión rara, pero no infrecuente (5-8%), suele ser secundaria a: caída con el pie en flexión plantar, una lesión al apoyar el pie en un bordillo resbaladizo, una inversión, eversion o abducción forzada del pie, o en accidentes de tráfico al pisar el pedal del freno.

Exploración física:

El pie afecto se presenta inflamado, equimótico y muy doloroso, con imposibilidad para el apoyo. La radiografía suele ser diagnóstica, hay que prestar atención a la relación del 2º metatarsiano con su cuña.



Fractura de Lisfranc

Pruebas complementarias:

proyecciones AP, lateral y oblicua interna a 30º y conocer las relaciones anatómicas para poder reconocerlas.

- En AP la cortical medial de la base del 2º MTT tiene que estar en línea con la cortical medial de la segunda cuña.
- En la lateral no debe existir escalones entre los bordes dorsales cueometatarsianos.
- En la oblicua interna, la cortical medial del tercer metatarsiano debe alinearse con la cortical medial de la cuña lateral.

Tratamiento:

La reducción se debe realizar lo antes posible para evitar compromisos nerviosos y circulatorios del pie. Esta se realiza traccionando de los metatarsianos en el eje y empujando las bases hasta reducción. Si es estable se inmovilizará con una bota de yeso suropédica; aunque frecuentemente son lesiones inestables que necesitan fijación quirúrgica.

FRACTURA DE LOS METATARSIANOS

Mecanismo lesional:

La causa más común es por un mecanismo de golpe directo o en el momento actual por accidentes de tráfico. Es una parte del pie muy susceptible a los traumatismos directos.



Fractura de los metatarsianos

Pruebas complementarias:

La radiología AP y Lateral es diagnóstica.

Tratamiento:

Las fracturas de las diáfisis no desplazadas (desplazamiento menor a 3 mm y angulación menor a 10°):

Plantilla dura o calzado rígido con apoyo según tolerancia al dolor

Bota de yeso y descarga en fracturas del primer metatarsiano o si el dolor es muy importante.

El resto de fracturas diafisarias precisan de corrección quirúrgica.

Las fracturas del cuello son ortopédicas salvo que estén muy desplazadas.

LUXACIONES METATARSOFALANGICAS

Lesiones infrecuentes

Exploración física:

se presentan con tumefacción y deformidad en hiperextensión.

Pruebas complementarias:

Rx AP y Lateral.

Tratamiento:

La reducción se lleva a cabo mediante la tracción en el eje del dedo. Una vez conseguida la reducción se inmoviliza con una sindactilia y movilización precoz.

FRACTURAS DE LAS FALANGES

Las más afectadas son las del primer y el quinto dedo.

Pruebas complementarias:

Rx AP y Lateral.

Tratamiento:

Inmovilización mediante sindactilia y calzado cómodo. En las fracturas del primer dedo, valorar la necesidad de cirugía si tienen afectación articular.

BIBLIOGRAFÍA

- Rodiño Padín, J., Benito Jiménez, A. Fracturas de Astrágalo y Calcáneo. En: Forriol Campos, F. Manual del Residente de C.O.T. SECOT 2009. P 441-447.
- Crespo Rivero, J.M., Picazo Martín, F. Fracturas del tarso, metatarso y dedos del pie. En: Forriol Campos, F. Manual del Residente de C.O.T. SECOT 2009. P 449-451.
- Casellas, G., Panadero M., Granero, J. Fracturas y lesiones traumáticas del pie. En Granero, J., Otero, R., Peidro, L. Manual de Traumatología. Medical & Marketing Communications. 2012. P:313-334.